

Довідник за матеріалами ефіру «Від дашбордів до управлінських рішень: як медзакладам використовувати дані НСЗУ. Частина 2»

Джерело: YouTube-ефір (канал «Доктор Булавінова»), спікер від НСЗУ — Василь **Формат**
довідника: тематичний виклад ключових тез + питання глядачів і відповіді на них

ЧАСТИНА I. АВТОМАТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ — КЛЮЧОВІ ТЕЗИ

1. Що таке автоматичний моніторинг

- Одна з ключових функцій НСЗУ: аналіз інформації в ЕСОЗ, виявлення ризиків і прогалин; основна мета — **ефективне використання коштів ПМГ**.
- **Не каральна функція** і не інструмент «забирати гроші у закладів». Це про **справедливість** (обмежений бюджет, оплата лише реально наданих послуг) і **прозорість**.
- Працює за **єдиними підходами до всіх надавачів** незалежно від форми власності (комунальні, приватні, ФОП) — одні алгоритми, однакові правила.
- Наразі — **понад 1000 автоматизованих правил перевірок**: електронні медичні записи, відповідність умовам договору та закупівлі, кадрове забезпечення, обладнання.

2. Як і ким визначається зміст моніторингу

- Постійний процес: відбувається **щоденно і по всіх закладах**, а не «по кнопці» раз на місяць/рік.
- Алгоритми затверджуються **внутрішніми наказами НСЗУ** і застосовуються однаково до всіх.
- Складові: перевірка ЕМЗ (результат заклади бачать у розшифровках), моніторинг кадрового забезпечення, відповідності обладнання — по всіх даних, які заклади вносять в ЕСОЗ.
- Перші алгоритми перевірки медичних записів розроблялися **з 2020 року** (старт модуля СМД). Впроваджена перевірка далі працює щоденно на постійній основі; база перевірок зростає кумулятивно (нові додаються щомісяця — від кількох штук до кількох десятків; відключаються рідко).

3. Масштаб даних ЕСОЗ

- Понад **5,5 млрд** електронних медичних записів.
- Понад **500 000** зареєстрованих користувачів системи.
- Понад **34 млн** активних пацієнтів зі сформованими електронними медичними картками.

4. Оверкодинг

- Загальна проблема: лікарі вносять недостовірну інформацію — додають зайві діагнози або штучно «підміняють» інтервенції, кодуючи складніші випадки замість простіших, з метою вищого фінансування.
- Наслідок: у системі може не вистачати коштів на оплату, нерівномірний розподіл коштів.
- НСЗУ аналізує тенденції та аномалії в ЕСОЗ і на їх основі впроваджує нові перевірки.

5. Зворотний зв'язок і робота із помилками

- Кожен перевірений медичний запис або **зараховується, або не зараховується**; у розшифровках виводиться опис помилки (кодування, адміністративна, невідповідність умовам договору — кадри/обладнання, технічна тощо).
- Очікування від закладів: аналізувати розшифровки, ставити питання «чи дійсно це помилка? чому вона трапилась?», виправляти та **будувати управлінські рішення** (навчання лікарів, організація процесів), щоб уникати повторення.
- Проблема: частина закладів виправляє одні й ті самі помилки систематично, з місяця в місяць — без управлінських заходів на місцях.

6. Ключова статистика (Школа загартовування НСЗУ, ~150 керівників ЗОЗ)

- **50,5% закладів за результатами 2025 року жодного разу не виправляли помилки через форму 066** — тобто кожен другий заклад взагалі не веде системну роботу над помилками цього типу (несвоєчасно внесені записи, помилки через форму верифікації — часто на значні суми).
- Це відповідальність **адміністрації закладу**: відсутній процес і контроль за функцією.
- Практичний наслідок: робота виконана «на 99%» (послуга надана, ресурси витрачені), але через помилку заклад не отримує відшкодування. Заклади, що не виправляють 10–20% записів, фактично недоотримують відповідну частку річного фінансування — і опиняються поза «ринковими умовами» відносно закладів, які працюють із розшифровками.

7. Приклади типових помилок

- **Не закритий епізод**: достатньо зайти в ЕМК і натиснути «завершити епізод» (2–5 хвилин) — і оплатиться запис, включно з послугами вартістю 20, 30, 40, навіть 100 тис. грн. Проте помилка має системний характер по багатьох закладах.
- Головна «системна помилка» — сам факт **невиправлення помилок** як управлінська прогалина.

8. Навчання лікарів: чия відповідальність

- **Адміністрація закладу**. НСЗУ надає роз'яснення **на заклад**, а не консулює

кожного лікаря окремо.

- У закладі має бути медичний директор/відповідальна особа, яка опрацьовує роз'яснення й організовує навчання. У кожному закладі є проактивні лікарі, які добре орієнтуються в кодуванні — вони можуть навчати колег, але процес має бути організований і керований керівником.
 - Канали комунікації з НСЗУ: міжрегіональні департаменти, офіційні звернення, **ранкові зустрічі** (можна ставити питання «з голосу»).
-

ЧАСТИНА II. ПИТАННЯ ГЛЯДАЧІВ ТА ВІДПОВІДІ

Декларації та пацієнти

П1. (Наталія) Діти-декларанти виїхали за кордон назавжди — неможливо виконати індикатори якості. Як автоматично розірвати декларацію? Технічної можливості розірвати декларацію немає: за порядком вибору лікаря декларація **безстрокова**. З точки зору оплати діє коефіцієнт звернень — за декларантів, які не звертаються **понад 3 роки**, НСЗУ перестає платити. Запровадження терміну дії декларації обговорювалося з МОЗ, але найближчим часом не планується. В ЕСОЗ розробляється функціонал статусу «**тимчасово неактивний**» пацієнта (за тривалої відсутності взаємодії із системою) — його враховуватимуть у статистичних індикаторах та оплатах. Обіцяти строки спікер не готовий; можливо, запрацює у 2027 році.

П2. (Світлана Філянович, ЦПМСД № 10) Помилку в прізвищі виправили в ЕСОЗ, але в роздрукованій декларації помилка залишається. Чому? Якщо дані пацієнта в ЕСОЗ актуалізовано, декларація має підтягувати їх автоматично. Ймовірно, виводиться **збережений, підписаний КЕП примірник** з даними на момент укладання. Варіант: **переподати декларацію**, щоб актуалізувати паперовий примірник.

П3. (Козаностра 261) Пацієнт оглянутий хірургом 01.06, прооперований 02.06 в іншому закладі, виписаний з поліпшенням — а «за НСЗУ померлий». Як так? Є щонайменше дві категорії перевірок: (1) смерть помилково зафіксована **безпосередньо в закладі** — як результат лікування замість «виписаний» поставили «померлий» (технічна помилка); (2) відомості про смерть надійшли з **ДРАЦС** (zareєстровано свідоцтво про смерть) — тоді пацієнту доведеться пройти низку процедур, щоб «стати живим» у державних реєстрах. Також важливо перевірити, чи не було **помилки ідентифікації** (схоже прізвище/ім'я, інша дата народження — звернення закодували іншому пацієнту). Якщо помилку допустив медпрацівник на амбулаторному прийомі — пацієнту слід звернутися до цього лікаря, щоб той **анулював запис** про смерть в ЕМК.

Строки, форма 066, виправлення помилок

П4. (Тетяна) За який період можна виправити помилки? 90 днів з дня надання послуги. За постановою № 1808 НСЗУ оплачує послуги, внесені до звіту не пізніше **10-го робочого дня** по закінченні звітного періоду (на практиці — до **14 календарних днів**; звітний період — календарний місяць). Виправлення після завершення цього вікна — у

межах 90 днів; якщо помилки виправляються шляхом **створення нових ЕМЗ**, додатково потрібна **форма 066** для підтвердження, що це саме виправлення.

П5. (Анна Кривовяз) Що вважається днем надання послуги для стаціонарного випадку — день відкриття чи закриття епізоду? День закриття. Відлік 90 днів іде від дати закриття.

П6. (Ольга Юдіна) Чи потрібно подавати форму 066 на виправлення по 9-му пакету? Залежить від виправлення. **Несвоєчасно внесені записи** можна не подавати — у розшифровці вони відображаються як такі, що підлягають включенню в статистику. **Пріоритетні послуги** — обов'язково через 066, інакше НСЗУ не сплатить. Йдеться про виправлення «заднім числом» у межах 90 днів.

П7. (Микола Дребот) Під час прийому немає зв'язку/актуального номера — послуга надана, а запис не внесено. Що робити? Запис можна внести пізніше, коли з'явиться технічна можливість (наступного дня, через 2–3 дні). За постановою № 1808 на первинне звітування є **14 календарних днів** (10 робочих) по завершенні звітного періоду, на виправлення помилок — **90 днів**.

Пакет 9, автентифікація, план лікування

П8. (Микола Дребот) Пацієнти не отримують СМС-підтвердження плану лікування по 9-му пакету — поліклініки втрачають кошти. Чи можна змінити підходи? Підходи до ідентифікації змінити можна, але це не знімає вимогу плану лікування. Уже працює **кабінет пацієнта**: авторизувавшись через КЕП, пацієнт може **самостійно виправити номер телефону**. Лікар може скористатися формою зміни номера телефону на сайті НСЗУ та скинути метод автентифікації. Якщо номера телефону немає — план лікування створюється відразу на основі доступу.

П9. (Ірина Морохова) Підлітки в центрах ментального здоров'я не хочуть, щоб батьки знали про звернення; без плану лікування послуга не оплачується. Якщо в ЕСОЗ вказано телефон батьків — СМС про план лікування прийде батькам; якщо телефон самого підлітка — підтвердження прийде йому. Швидкої відповіді/готового алгоритму для врегулювання цієї ситуації спікер наразі **не має**.

Платні послуги

П10. (Тетяна Павлович) Первинка надає платні передрейсові огляди водіїв юрособі. Під яким кодом вносити? Чи щодня? Кодується як **взаємодія**; як підставу надання послуги використовується електронне або паперове направлення з приміткою «**платна послуга**» — так взаємодія позначається як така, що не належить до ПМГ. Є окремий лист-роз'яснення щодо внесення платних послуг. За порядком реалізації постанови № 1808 **усі надавачі з договорами НСЗУ зобов'язані звітувати про всі платні послуги** незалежно від напряму контрагування. Вносити — **щодня, під час прийому**: ЕСОЗ — це передусім інструмент ведення медичних записів, а не звітування.

П11. (Ольга Геладкова) Чи звітувати про платні послуги іноземним громадянам? Ні — йдеться лише про громадян України. Технічно ЕСОЗ наразі **не**

дозволяє зареєструвати іноземних громадян, тому виконати норму щодо них неможливо.

П12. (Тетяна Прийма) Як лабораторії вносити платні послуги, якщо лікар не створює е-направлення з іншим джерелом фінансування? Якщо пацієнт без сімейного лікаря? Наявність сімейного лікаря **не має жодного значення** ні для платних послуг, ні для направлень. Працівник лабораторії при створенні діагностичного звіту може використати **паперове направлення** з позначкою «платна послуга»; це можна автоматизувати шаблонами в МІС. Краща практика: той, хто направляє, одразу генерує направлення на **інші програми фінансування** — тоді лаборант просто виконує і закриває направлення, послуга автоматично класифікується як платна.

П13. (Катерина Горієнко) Скринінг 40+: невірний ЄМЗ визнали помилковим через 066, вірний внесли в червні, а гроші зайшли у травні. Чи правильно? Скринінг 40+ — не ПМГ, це окрема програма: НСЗУ за епізоди скринінгу безпосередньо не платить, і звітувати по ньому у форму 066 не потрібно (066 стосується лише ПМГ та пілотних проєктів на кшталт зубопротезування). При перевнесенні записів важливо вказувати **реальну дату надання послуги** — система фіксує окремо дату послуги і дату внесення, а НСЗУ аналізує саме за датою надання. На виправлення — 90 днів, без 066.

Пакет 54 (реабілітація)

П14. (Максим Бондарчук) Якщо в супутніх діагнозах є діагноз і для АР-1, і для АР-2 — епізод відносять до АР-2, хоча допомога надавалась як монопослуга. Чи буде переглянуто обрахунок? Якщо випадок за критеріями підпадає під монопослугу — він піде в монопослугу. Як АР-2 такий випадок не оплатиться: послуга мультидисциплінарної команди — це фактично **щоденні заняття не менше 14 днів**, а монопослуга — **2 візити на тиждень** (різні тривалість та обсяг). Якщо випадки не зараховуються — звертатися до міжрегіональних департаментів за роз'ясненням; можливо, є помилка обліку на боці закладу.

П15. (Хіаомі 2506) Чи оплатять записи по 54-му пакету, розпочаті у квітні і завершені у травні (у розшифровці за травень не оплачені)? Перехідний період діє для випадків, розпочатих у квітні **за старими правилами кодування діагнозів**, — вони зараховуються у травні (і стаціонарна, і амбулаторна реабілітація). Але **з травня НСЗУ припинила оплату АР-1/АР-2 закладам, які не відповідають додатковим вимогам** — на відповідність додатковим вимогам перехідного періоду **немає**.

Стаціонарне лікування та консультації

П16. (Наталія) Чи враховуються консультації вузьких спеціалістів під час стаціонарного лікування (ВЛК, направлення на МСЕК/«ЕКПФ»)? Оплата стаціонарного випадку не змінюється, консультації враховуються. У межах **одного закладу** — за специфікацією та умовами закупівлі стаціонарного пакету заклад **зобов'язаний** за наявності показань забезпечити консультації широкого спектра фахівців (це не консультації по 9-му пакету, а частина обсягу стаціонарного лікування; те

саме стосується амбулаторних інструментальних досліджень — вони входять в обсяг, навіть якщо не впливають на оплату випадку).

П17. (Яна Китаєва) Пацієнт у стаціонарі потребує консультації спеціаліста з іншого закладу — амбулаторний візит іде «в перекриття»? Між різними закладами перекриття амбулаторного візиту стаціонарним лікуванням немає: консультацію іншому закладу НСЗУ зараховує, у т.ч. із застосуванням телемедицини.

П18. (Наталія, уточнення) Не зараховується амбулаторна консультація в іншому закладі при стаціонарному лікуванні. В іншому закладі — зараховується. Питання, можливо, у кодуванні конкретних випадків: треба розбирати індивідуально.

П19. (Тетяна Пищик) Пацієнти на інсуліні приходять на амбулаторний прийом за рецептом, перебуваючи на стаціонарному лікуванні. Якщо це різні заклади — консультації зараховуються автоматично. Питання вже врегульовано (порушувалося на ранковій зустрічі): консультація ендокринолога, що стосується саме **виписки рецепта на інсуліни**, зараховується **додатково у 9-й амбулаторний пакет** — вона не входить у базовий обсяг стаціонарного пакету.

П20. (Xiaomi 25069) Алгоритм оплати медичних записів до однієї доби при переведенні до інших ЗОЗ. Залежить від пакету: при **інсульті** переведення до однієї доби оплачується за умови виконання базових мінімальних обстежень; у **стаціонарному лікуванні** переведення до однієї доби не оплачується; у **хірургії** окремі випадки з переведенням оплачуються. Різні ДСТ, діагнози та клінічні ситуації — усе індивідуально. Рекомендація: звернутися до НСЗУ (міжрегіональні департаменти, офіційно або ранкові зустрічі) з конкретними прикладами.

Верифікація пацієнтів

П21. (ДОЗ Дніпро) Новий показник верифікації пацієнтів з реєстром ДМС — як застосовуватиметься? Уже застосовується і враховується у звітах (орієнтовно з **1 травня**). Пацієнт вважається верифікованим, якщо пройшов верифікацію **хоча б за одним напрямом**: ДРАЦС, ДРФО, свідоцтво про народження, паспорти, ЄДДР, або ручна верифікація.

Дашборди, відкриті дані, доступ до інформації

П22. (Михайло) Графіки кількох показників — нерозрізнявані відтінки голубого. Зробіть контрастну схему. Проблема відома, зміна запланована — зроблять найближчим часом.

П23. (Михайло / MOR1s) Потрібен експорт даних дашбордів в Excel. НСЗУ використовує Microsoft Power BI для публічної звітності, і **функціонал Power BI у публічному доступі обмежує експорт** — це обмеження платформи, а не НСЗУ. Альтернативи: **аналітичні звіти за областями** (велика частина дашбордних даних в Excel-вигляді); з окремих дашбордів дані можна експортувати зі зведених таблиць — є «лайфхак» та **інструкція зі скріншотами на сайті НСЗУ**.

П24. (Михайло) CSV у відкритих даних: обмежений набір, назви файлів не відповідають вмісту. Визнано: останніми роками структурованим відкритим даним приділялося мало уваги через брак внутрішніх ресурсів (напряму розвивається «за залишковим принципом»). У планах — **Open Data 2.0:** реінжиніринг і суттєве розширення наборів структурованих даних (зокрема з огляду на придатність CSV для автоматичного аналізу, у т.ч. із застосуванням ШІ). Сподівання реалізувати цього року — залежно від ресурсів. Файл «доходи та витрати» перевіряють.

П25. (Юлія Машкова, Ізюмська МТГ) Як громаді впливати на роботу з помилками закладів і отримати інформацію про свій заклад? Три інструменти: (1) **аналітичні звіти за областями** щодо стану реалізації ПМГ — 17 розділів (договори, первинка, декларації, рецепти, оплати, фінансові звіти 1-НС, 1-ПМГ, маршрути по інсульту/інфаркту, реімбурсація) в одному Excel-файлі у розрізі закладів області; (2) **дашборди** — присутні всі заклади; (3) **відкриті дані у CSV** — потребують аналітичних навичок, але доступні.

П26. (Юлія Машкова) Чи можлива консультативна менеджерська підтримка НСЗУ для виведення закладу з фінансової кризи? Міжрегіональні департаменти НСЗУ консультують керівництво лікарень (контрактування, роз'яснення, звітність, оплати, реорганізації, виправлення помилок) — це одна з їхніх основних функцій. За потреби можлива навіть організація зустрічі з окремою лікарнею за запитом керівника до НСЗУ.

П27. (Тарас Чендей) Кілька днів немає доступу до дашбордів та аналітичних звітів. Найімовірніше, локальна проблема: сайт НСЗУ працює, сервіси доступні. Рекомендація — перевірити комп'ютер, почистити кеш.

П28. (Олександр Громовий) Розділити на дашборді декларацій вікову групу 40-64 на 40-55 і 56-64; додати фільтр верифікації. Розділення вікової групи заплановано (менш пріоритетна задача). Для первинки вже є **окремі дашборди з показниками роботи ПМД:** поділ за віковими групами, показники верифікації (загальні, за віком, за реєстрами), коефіцієнт звернень. Ця ж інформація є в аналітичних звітах і в щомісячному звіті по роботі надавача ПМД, який централізовано розсилається всім надавачам.

П29. (Любов Мартинова) Зробити в дашбордах вікову групу пацієнтів за кожним лікарем у деклараціях, у вигляді розширеної таблиці. Уже реалізовано: на дашбордах у розбивці по лікарях показники деталізуються, у т.ч. за віком, статтю, у динаміці. Таблиці дашбордів працюють як **зведені (pivot):** через параметри й показники користувач може сам конструювати рядки/стовпці та власні подання. **Інструкція користування дашбордами є на сайті.**

П30. (Назар Козовий, Коломия) Навчіть ДОЗи та органи влади користуватися дашбордами — вони досі вважають паперову звітність еталоном. МОЗ активно користується дашбордами; в окремих областях і громадах — теж, але нерівномірно. Навчальні ініціативи для ОМС і ДОЗів проводилися в минулі роки; через ротацію кадрів їх

доводиться повторювати. Це не пряма функція НСЗУ, але служба періодично долучається з вебінарами, щоб підвищувати data-грамотність.

Дашборди для керівника закладу

П31. Навіщо керівнику дашборд і що дивитися? Якщо керівник не аналізує свої дані — **за нього це зробить система** (зокрема НСЗУ в межах автотестування), і результат такого аналізу може керівнику не сподобатись. Ключові дашборди для керівника:

1. **Укладені договори** — свої пакети та пакети сусідніх закладів, для координації маршрутів пацієнтів.
2. **Фінансова звітність (звіти 1-НС)** — усі комунальні заклади, поквартально й річно за ~6 років, близько сотні показників: закупівлі, витрати, рух коштів, середня зарплата; можливість порівняти свій заклад з будь-яким закладом країни (альтернативних інструментів такого автоматизованого порівняння не існує).
3. **Структура надання послуг за ПМГ** — обсяги, розподіл між пакетами, популярні ДСГ-групи; співставлення з «типовим портретом» кластерного/надкластерного/приватного закладу, по громаді, області, країні — для визначення зон розвитку та сильних сторін.

Інше

П32. (Берзой) Чому не створити для е-лікарняних (МВТН) первинну перевірку ПФУ на наявність трудових відносин, і лише за наявності — експертизу лікаря? Не в компетенції спікера — питання до Пенсійного фонду; можна буде адресувати Дмитру Чернишу в одному з наступних ефірів.

П33. (Family Мед) Додайте авторизацію в кабінеті пацієнта через BankID, Приват, Моно тощо. Функціонал електронного кабінету пацієнта покращуватиметься; з часом з'являться інші канали авторизації.

П34. (Марія Ковкон) На якому етапі питання амбулаторної психіатричної допомоги із застосуванням примусових заходів медичного характеру (значні затрати на юрсупровід і судові засідання)? Ймовірно, йдеться про 72-й пакет (мобільні мультидисциплінарні команди) — не готовий відповісти, цим займається інший структурний підрозділ НСЗУ.

П35. (Марія Ковкон) Чому не впроваджено коефіцієнт для лікування військових, зокрема ПТСР? ПМГ щороку переглядається за пріоритетами і тарифами. Минулого року вперше запроваджено **доплати за бойову травму** (основні зміни — по хірургічному пакету); також діють додаткові виключення з правил для військових у пакетах реабілітації, хірургії та інших. Структура і попит на послуги враховуються при розробці ПМГ на наступний рік.

КОРОТКИЙ ЗВІД КЛЮЧОВИХ ЦИФР І ПРАВИЛ

Параметр	Значення
Автоматизованих перевірок	понад 1 000
ЕМЗ в ЕСОЗ	понад 5,5 млрд
Користувачів ЕСОЗ	понад 500 тис.
Активних пацієнтів	понад 34 млн
Закладів, що жодного разу не виправляли помилки через ф. 066 (2025)	50,5%
Строк первинного звітування	10 робочих (~14 календарних) днів після звітного місяця
Строк виправлення помилок	90 днів з дати надання послуги (для стаціонару — з дати закриття епізоду)
Припинення оплати за «неактивного» декларанта	після 3 років без звернень (коефіцієнт звернень)
Ф. 066	лише ПМГ та пілотні проекти; обов'язкова для пріоритетних послуг і при виправленні шляхом створення нових ЕМЗ

Довідник складено за транскриптом ефіру; формулювання відповідей узагальнено зі збереженням змісту. Для офіційного застосування норм слід звірятися з постановою КМУ № 1808 та листами-роз'ясненнями НСЗУ.